

HIV ואיידס בהלכה

הרב ד"ר אשר טרגין

פתיחה: מחיר השתיקה

נגיף ה-HIV, הגורם למחלת האיידס, העמיד בפני עולם ההלכה שורה של שאלות — רפואיות, חברתיות ומוסריות. בישראל של תחילת שנות האלפיים אובחנו מדי שנה מאות נדבקים חדשים, ובהם גם אנשים מהציבור הדתי, שחלקם לא זכו במסגרות החינוך לשום שיח על הסיכונים שבהתנהגות מינית לא מוגנת. חוברת ההסברה "ונשמרתם", שנכתבה בליווי רבני, ביטאה את העיקרון בבהירות: לשתיקה יש מחיר — נושא שאיננו מדברים עליו איננו קיים בתודעה, וכשהוא מתרחש, הדרך להתנהגות מסוכנת קצרה מאוד. במאמר זה נעבור על השאלות ההלכתיות המרכזיות שמעורר הנגיף.

"ייסורי החוטאים"?

טענה שנשמעה בשולי השיח הציבורי גרסה שהאיידס הוא "עונשם של החוטאים", וממילא אין החברה חייבת בטיפול בו. טענה זו שגויה מיסודה, משתי סיבות. ראשית, עובדתית: רבים נדבקו בנגיף בלא כל קשר לעברה — מקבלי עירוי דם (בייחוד בשנות השמונים, בטרם פותחו בדיקות הסינון), תינוקות שנדבקו ברחם אמם, אנשי צוות רפואי שנדבקו ממטופלים, ובני זוג תמימים שלא ידעו דבר. שנית, ועקרונית יותר: גם חולה שחלה בעקבות מעשיו — חובת הרפואה והחסד כלפיו בעינה עומדת; איננו מתנים הצלת נפשות בצדקת החולה. הרופא המסרב לטפל בחולה "חוטא" — מוסיף חטא על פשע.

נישואין של נשא HIV

האם נשא HIV רשאי להינשא? השאלה ההלכתית המרכזית כאן היא חשש "רודף": קיום יחסי אישות ללא ידיעת בן הזוג עלול להעמידו בסכנת חיים. מכאן עולה חובת גילוי מלאה — נשא חייב ליידע את בן זוגו המיועד על מצבו, והסתרה היא סיכון חיי הזולת ממש. ואולם משנעשה הגילוי, ומשקיימים אמצעים המפחיתים את הסכנה (ראו להלן), אין מניעה עקרונית מנישואין — והדברים נמסרים להכרעת פוסק ורופא בכל מקרה לגופו.

סודיות רפואית — לשון הרע מול תועלת

האם רופא היודע על מטופל נשא רשאי — או חייב — לגלות זאת? מחד עומד איסור לשון הרע ורכילות; מאידך, כאשר יש בגילוי הצלת אחרים, הרי זו לשון הרע לתועלת,

שהחפץ חיים עצמו מתירה ואף מחייבה בתנאים ידועים. הרב י"ד בלייך העמיד שיקול מערכתי כבד משקל לצד הסודיות: אם הסודיות הרפואית לא תהיה מובטחת, אנשים פשוט יימנעו מלהיבדק – וכך יאבדו את הזדמנות הטיפול המוקדם וימשיכו להדביק אחרים בלא יודעין. נמצא שדווקא השמירה על הסודיות היא המגינה על בריאות הציבור, והחריגה ממנה שמורה למצבים שבהם אדם מסוים ומזוהה נתון בסכנה מיידית שאין דרך אחרת למונעה.

אמצעי מניעה ופיקוח נפש

ההלכה מסתייגת דרך כלל משימוש באמצעי מניעה חוצצים, מדין השחתת זרע ומצוות פרייה ורבייה. ואולם כאשר מדובר במניעת הדבקה במחלה מסכנת חיים, השתנה השיקול מן היסוד: פיקוח נפש דוחה את ההסתייגות, והפוסקים התירו שימוש באמצעים אלו לבני זוג שאחד מהם נשא. אין התורה דורשת מחולה איידס פרישות עולמית – היא דורשת אחריות.

חובת הרופא וסיכנו

האם רשאי רופא להימנע מטיפול בחולה איידס מחשש הידבקות? העיקרון ההלכתי שנקבע בפוסקים: כאשר הסיכון זעיר, או שאינו עולה על סיכונים שאדם נוטל על עצמו דרך שגרה לצרכיו – נסיעה בכביש מהיר, טיסה – אין הרופא רשאי להשתמט מחובתו בטענת סכנה מדומה. בפועל, עם אמצעי מיגון סטנדרטיים, הסיכון לצוות רפואי נמוך ביותר.

מקווה, טהרה וברית מילה

שלושה תחומי מעשה שעוררו חשש ציבורי: א. מקווה – הנגיף אינו שורד במים, ואין כל יסוד למנוע מנשא טבילה במקווה. ב. טהרת המת – אנשי חברה קדישא עלולים לכאורה לבוא במגע עם נוזלי גוף; בעבודה בכפפות הסיכון אפסי, ובשונה מחדר ניתוח אין שם מחטים וחפצים חדים העלולים לנקב את הכפפה. ג. ברית מילה – החשש נגע למציצה בפה אצל תינוק שנדבק מאמו. בספרות התקופה הוצע חיטוי בכוהל בריכוז גבוה, שהנגיף אינו שורד בו; ובימינו הפתרון הרווח והמומלץ רפואית הוא מציצה בכלי (שפופרת), הנוהגת ממילא בקהילות רבות ומסלקת את החשש כליל.

איסור משכב זכור

אין לנתק את הדיון מן הרקע ההלכתי של האיסור: "וְאֵת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תוֹעֵבָה הִוא" (ויקרא יח, כב). ספר החינוך מבאר את טעם המצווה: "השם ברוך הוא חפץ ביישוב עולמו אשר ברא, ולכן ציווה לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים... והאיש

שנברא לעבודת בוראו לא ראוי לו להתנוול במעשים מכוערים כאלה". יצוין שבתנועה הקונסרבטיבית הוצעה קריאה מחודשת של האיסור, כאילו הוא מופנה רק אל מי שיש לו משיכה טבעית לבני המין השני; ההלכה האורתודוקסית לא קיבלה קריאה זו. ואולם — וזו הנקודה המכרעת — האיסור שבתורה אינו גורע כהוא זה מחובות הרפואה, החסד וכבוד הבריות כלפי החולה. ההלכה מבחינה הבחנה חדה בין היחס למעשה ובין היחס לאדם.

ואהבת לרעך כמוך

זו גם השורה התחתונה של הסוגיה כולה. חולה האידס — יהיו נסיבות הידבקותו אשר יהיו — הוא אדם שנברא בצלם, שחלים עליו כל דיני ביקור חולים, רפואה, סודיות וכבוד. הבהלה הציבורית שליוותה את המגפה בעשוריה הראשונים הולידה נידוי והרחקה שאין להם מקום בהלכה: לא במקווה, לא בטהרה, לא בברית, ולא בקבלת האדם בקהילה. "ואהבת לרעך כמוך" — גם, ואולי בעיקר, כשהרע חולה ומפוחד.

הערת עדכון רפואי

הנתונים והחששות שבמאמר משקפים את תקופת ההרצאה המקורית. מאז השתנתה תמונת המחלה מן הקצה: טיפול אנטי-רטרוויראלי מודרני מאפשר לנשאים חיים מלאים ותוחלת חיים תקינה, ונשא מטופל שעומסו הנגיפי אינו ניתן לגילוי — אינו מדביק ($U=U$). עובדות אלו מחזקות את המסקנות ההלכתיות דלעיל: חובת הבדיקה והטיפול המוקדם, ערך הסודיות המעודדת בדיקות, והיעדר כל הצדקה להרחקת נשאים מחיי הקהילה והמצוות.